MÓDULO 1 · FUNDAMENTOS DE MEDICAL AFFAIRS Y SU ROL ESTRATÉGICO

Cómo se mide el impacto de Medical Affairs

Medir el impacto de Medical Affairs es genuinamente más difícil que medir el desempeño comercial, y entender por qué es el primer paso para hacerlo bien. Las funciones comerciales tienen un proxy limpio e inmediato de éxito — volumen de ventas, cuota de mercado, número de prescripciones — que se conecta de forma directa y rápida con la actividad individual de un representante. Medical Affairs, por diseño, no tiene — y no debería crear — una métrica equivalente, porque vincular la actividad médica a un número similar al de ventas comprometería precisamente la independencia que hace creíble a Medical Affairs en primer lugar.

- Comercial tiene un proxy limpio: volumen de ventas
- Medical Affairs no debería crear un equivalente — comprometería su independencia
- El primer paso es entender por qué no existe esa métrica

Durante mucho tiempo, esta brecha de medición llevó a Medical Affairs a apoyarse en gran medida en métricas basadas en la actividad: número de interacciones con KOLs, número de solicitudes de información médica respondidas, número de publicaciones apoyadas. El análisis del sector critica cada vez más este enfoque, y con razón: contar interacciones no dice nada sobre si esas interacciones cambiaron algo. Un MSL puede registrar cincuenta visitas de campo de alta calidad en un trimestre y generar cero insights que lleguen a influir en una decisión, mientras que otro MSL registra la mitad de visitas pero saca a la luz un único insight que remodela un plan de generación de evidencia. Volumen de actividad e impacto sencillamente no son lo mismo.

ACTIVIDAD ≠ IMPACTO

- Nº de interacciones, solicitudes respondidas, publicaciones apoyadas
- Contar interacciones no dice si cambiaron algo
- 50 visitas sin insights vs. 25 visitas con 1 insight que remodela un plan

La dirección hacia la que se mueve el sector — reflejada en investigación reciente de MAPS y de métricas de campo médico — es hacia KPIs basados en resultados, ligados a la atención al paciente, el cambio en la práctica clínica y la calidad de la evidencia, en lugar de puros recuentos de actividad. En la práctica, esto se traduce en hacer seguimiento de cosas como: el número de insights médicos sobre los que realmente actuó un stakeholder interno (no solo registrados); cambios mensurables en la práctica clínica o en el posicionamiento de guías a los que la relación médica de campo contribuyó de forma plausible; la calidad y el uso posterior de la evidencia generada con aportación de Medical Affairs (citas, inclusión en guías, presentaciones a HTA); y feedback cualitativo — de KOLs, de compañeros internos de comercial y market

access, de equipos de generación de evidencia — sobre si la aportación de Medical Affairs fue genuinamente útil.

4 COSAS QUE SÍ SE MIDEN HOY

- Insights sobre los que un stakeholder realmente actuó
- Cambios mensurables en la práctica clínica o las guías
- Calidad y uso posterior de la evidencia generada
- Feedback cualitativo de KOLs y compañeros internos

Una segunda tendencia complementaria es un mayor énfasis en la evaluación cualitativa junto a los KPIs cuantitativos: feedback estructurado de KOLs, satisfacción de stakeholders internos con el apoyo médico, y casos documentados de caminos desde el insight hasta la acción. Las métricas cuantitativas responden a "cuánto hicimos"; la evaluación cualitativa responde a la pregunta más difícil e importante: "¿importó?".

CUANTITATIVO + CUALITATIVO

- **Cuantitativo:** responde "¿cuánto hicimos?"
- **Cualitativo:** responde "¿importó?" — la pregunta más difícil

Para un MSL individual, este cambio tiene una implicación práctica directa: la manera en que construyes tu propio caso de impacto — en una evaluación de desempeño, en una conversación de promoción, en la habilidad de "informe ejecutivo" cubierta en el Módulo 8 — no debería apoyarse principalmente en cuántas visitas completaste. Debería construirse sobre un pequeño número de ejemplos bien documentados en los que un insight concreto que capturaste, una conversación científica concreta que tuviste, o un apoyo concreto a la generación de evidencia que proporcionaste, condujo a un resultado trazable. Esa es la evidencia que una organización moderna de Medical Affairs realmente busca.

- No construyas tu caso de impacto sobre el número de visitas
- Apóyate en pocos ejemplos bien documentados con un resultado trazable
- Esta habilidad se cubre en el Módulo 8 (informe ejecutivo)